



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رابعياً : حسنه صابر على حسن
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : حلوان
رقم البطاقة : 28407020102941 رقم التليفون : 01152367781
العنوان : عرب غنيم
العمر (تاريخ الميلاد) : 02-07-1984 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 07-10-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: حسنه صابر علي حسن National ID: 28407020102941	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



10/2/54

5

2000

9.

و اع بالمدى الاول

23

1102 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

النسب المصرية
صحة
مصر

04/20/2026

MDT FORM

Name:	علي حسن Saber حسنه	MRN:	7640
Age:	42 Y	ID:	28407020102941
Menopausal Sta		Phone:	01152367781
NRS SCORE:		Marital Status:	
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:		Reason Of MDT:	post op

Clinical Data:

BX: mix inv duct an inn lobular G2
ER: 8 PR: 8 HER2: 1 KI67: 15

R

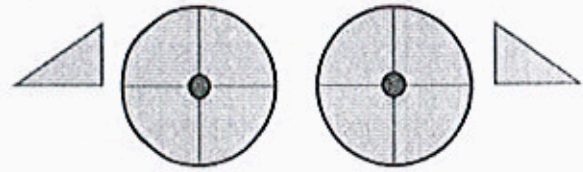
L

Sonomammography:Mets Workup:History:Recommendations:

post op It WLE + SLN free margin
LN 0/6
T1c pN0 (sin)

MDT Outcome & Plan

PORT
ZOLADEX +AI



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/ ترمين مصطفى					

Name: حسنه صابر علي حسن		
MR. : 7640		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient is receiving adjuvant therapy with femara 2.5 mg and zoladex 10.8 mg, with supportive care, and the next visit is scheduled for 8/8/2026. The patient is a 42-year-old with left breast cancer that was operated on with a wide local excision (WLE). The tumor was pT1, node negative, and luminal. Adjuvant hormonal therapy with an aromatase inhibitor (AI) was started in May 2026, and the patient received 17/20 doses at Ahemed Maher. The patient completed a PORT (PORTH) of 40 Gy in 15 fractions, with the last fraction delivered on 11/8/2026. On examination, there is a skin ulcer at the port site due to radiation, with an inflamed nipple. No masses or lymph nodes are noted. The patient is scheduled for a second-line systemic therapy (SM) after 3 months.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 20-09-2026
	الطبيب المعالج : نهى سعيد علي محمد	
يعتمد ,		

٧٦٤

Patient Name :	الأسفاده / حصفه صابر علي	Request No. :	13004314
Patient No. :	28407020102941	Request Date :	01/01/2026
Path No. :	3/26	Verification Date :	10/01/2026
Sex :	Female	Financial Category :	جوستاف روسي - ميارده
Age :	41 Y	Department :	Out Patient
Referring Doc :		Registered by :	Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast LOQ mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 01/01/2026, at 9:40 am.

Gross Examination:

- Two fragmented grey white tissue cores, measured 1 cm & 0.5 cm long. Totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5) & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade 2 (differentiation 2, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).
- * DCIS: Focal low & intermediate grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform pattern with comedo type necrosis).
- * Angioinvasion: Absent.
- * Perineural invasion: Absent.
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
 - ER: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).
 - PR: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).
 - Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
 - Ki67%: 15%.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.
- Focal low & intermediate grade ductal carcinoma in situ (Solid & cribriform pattern with comedo type necrosis).

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 18/01/2026 10:40:59

Page 1 of 3

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



شرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذة / حمنة صابر علي	Request No. : 13004314
Patient No. : 28407020102941	Request Date : 01/01/2026
Path No. : 3/26	Verification Date : 10/01/2026
Sex : Female	Financial Category : جوستاف روسي - مبادئ
Age : 41 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Low (score 1+).
- Ki67%: 15%.

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%

and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of

the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.

Dr. Heba El-Shafeey.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 18/01/2026 10:40:59

Page 2 of 3

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



شرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	: الأستاذة / حسنه صابر علي	Request No.	: 13004314
Patient No.	: 28407020102941	Request Date	: 01/01/2026
Path No.	: 3/26	Verification Date	: 10/01/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوماتاف روسي - مبادره
Age	: 41 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 18/01/2026 10:40:59

Page 3 of 3

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



اسم المريض: حسنه صابر

التاريخ: 2025/12/30

**Digitalized Low Dose Soft Tissue Mammography With
Complementary Breast US Examination Of Both Breasts Revealed:**

- ACR b : Mixed fibro-fatty-glandular breast parenchyma.
- Left breast asymmetrical and few small well defined lesions by mammography, corresponding by US to few small hypoechoic lesions seen at 3-4 o'clock surrounded by causing posterior shadowing. The largest measures 10x9 mm.
- No pathological microcalcification clusters.
- No right breast solid or cystic lesions.
- Normal central ducts system.
- Normal skin thickness and contour as well as nipple areola complexes.
- Left axillary show few enlarged lymph nodes , largest of them show thickened cortex measuring 5 mm.
- Right axillary non specific lymph nodes showing preserved fatty hila.

Opinion:

- Left breast LOQ suspicious lesions (BIRADS IV); for further assessment with Dynamic MRI/ contrast mammography and pathological correlation.

Dr. Marwa M. Selim, MSc

د. مروان صابر
٢٠٢٥ - ١٢ - ٣٠

Name : hosna saber ali

Branch : Portable

Ref.Physician Prof : ct cap +c

Date : 31-01-2026 11:05

Medical No. : GRI-28407020102941

Ins.Company :

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE

CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

I- CHEST:

- Clear both lungs showing no sizable pulmonary nodules, consolidation or cavitation.
- No pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No plural or pericardial collection.
- No gross cardiomegaly

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous low parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Mildly enlarged spleen showing homogenous parenchymal attenuation.
- Normal C.T appearance of Both kidneys, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No pathologically abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

Opinion:

- ❖ Fatty liver.
- ❖ Mild splenomegaly.

Dr. Nourhan Mohamed,MD

Dr. Nourhan Mohamed,MD

Patient ID: 93211	Patient Name English: Hosnah Saber Ali Hassan
Age: 41 Y	2026/02/08 09:47:41 AM : Report Date

Contrast enhanced Spectral Mammography

CLINICAL SUMMARY: 41 years old female patient with pathologically proven LT invasive ductal carcinoma with DCIS.

CC & MLO low energy & recombined (post contrast) images

FINDINGS:

Background Uptake: Mild background enhancement.

ACR: C (heterogenous dense)

Left breast:

- **Low energy (Non contrast) images:** Left breast shows UOQ multiple intercommunicating irregular shaped spiculated dense lesion associated with suspicious microcalcifications.
- **Recombined (Post contrast) images:** Left breast shows UOQ 3:00 clumped non-mass enhancement and measuring about 9.2x5.5 cm at its max. diameters , Located at 1.2 cm from the nipple.
- **Complementary US:**
 - Multiple small irregular spiculated heterogeneous hypoechoic masses, almost touching the overlying skin. The most anterior lesion is seen just retroareolar along with retroareolar dilated ducts.
 - No pathological axillary LNs, apart from one indeterminate see at level 1, measuring about 21x7 mm with 3.6 mm focal cortical thickening.

Right breast:

- **Low energy (Non contrast) images** No asymmetry or distortion or suspicious microcalcifications.
- **Recombined (Post contrast) images** show faint non mass enhancement involving the retroareolar region likely part of background enhancement.
- Normal skin / nipple / areolar complex.

IMPRESSION:

LEFT BREAST: (BIRADS 6= pathological proven) Left UOQ non-mass enhancement as described above.

RIGHT BREAST: (BIRADS 1= Normal study)

Best regards,

Dr. Ghada Khaleel, MSc